2.限制

血肌酐>265时不能再让肾单位休息了,否则大家都休息了

①限水、限钠：少尿期每日补液量=前一日尿量+500ml；多尿期每日补液量=每日排出水的 1/3-1/2

②限磷：用不含钙的磷结合剂——司维拉姆、碳酸镧（母 0 兰花指）

钙多了怕引起转移性钙化

③限蛋白、限脂、限药（氨基糖苷类、一/二代头孢菌素、非甾体类解热镇痛药、含马兜铃酸的中药等）

肾毒性、耳毒性　一→二→三 肾毒性越来越↓

前列腺素↓→肾血管收缩,肾缺血

④保证热量，防止负氮平衡

分解蛋白质出现恶病质

只有倾倒综合征高脂饮食

专题串联·透析

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）指征

K^+＞6.5 或严重心律失常，pH＜7.2，Cr＞442 或 707，BUN＞21.4

严重尿毒症（心包炎、脑病、癫痫），利尿无效的严重肺水肿（呼吸困难等）

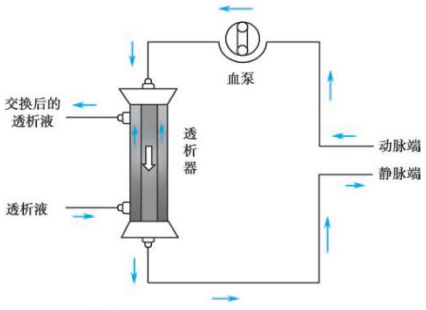


图 5-11-1　血液透析体外循环示意图

（二）方法

①间歇性血液透析

②连续肾脏替代疗法 CRRT：连续性静-静脉和动-静脉血液滤过

③腹膜透析：严重 AKI 因效率低、且易并发腹膜炎而不宜使用

（三）透析相关并发症

动脚评价人

①高排量心衰：透析时使用动静脉内瘘（内瘘是指动静脉在皮下吻合建立的血管通路）长期血透患者

②加重动脉粥样硬化（透析禁忌脂溶性中毒）湍流造成血管内皮损伤

③骨再生不良 透析液含钙过高,让PTH相对偏低,连成骨剂量都达不到

④透析失衡综合征：多发生在初次透析者，颅内高压表现（恶心、呕吐、头痛）

⑤透析相关性淀粉样变骨病 淀粉样蛋白质沉积在骨头

表 5-11-1　血液透析的并发症

透析失衡综合征	心律失常
低血压	低血糖
血栓	出血和急性溶血
空气栓塞	透析相关淀粉样变性
痛性肌痉挛	蛋白质-能量营养不良
透析器首次使用综合征	血小板减少症
发热	

真题解析·肾衰竭

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

慢性肾衰竭　靶器官功能损害　高血压急症

1.2012N102-104 A 男性，45 岁。间断全身轻度水肿 5 年，加重伴视物模糊 1 天入院。测血压 180/135mmHg，化验尿蛋白(++)，尿沉渣镜检 RBC 8-10 个/HP，24 小时尿蛋白定量 1.3g，血 Cr 337 μmol/L。

>265

102.该患者首选的治疗措施是

A.血液透析

B.利尿治疗

C.降压药物治疗 面对高血压急症,用扩血管药降压-硝普钠

D.摄入低盐、低蛋白饮食